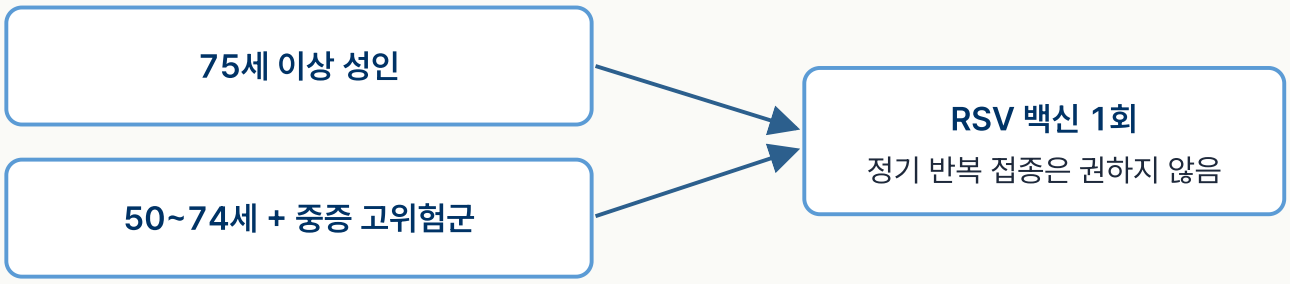
RSV 백신, 나이와 중증 위험을 함께 봐요

호흡기세포융합바이러스(RSV)는 고령자와 기저질환이 있는 분에게 심한 호흡기 감염을 일으킬 수 있습니다. 2026년 강의의 접종 안내입니다.

권고 대상에게 1회 접종합니다



75세 이상 성인, 또는 50~74세 중 중증 RSV 감염 위험이 높은 분에게 1회 접종을 권고합니다.

시기와 횟수

접종 시기	연중 접종할 수 있습니다. 강의에서는 유행이 10월 말~3월 말 정도라 가능하면 8~10월 접종을 설명했습니다.
반복 접종	현재 정기적인 반복 접종은 권고하지 않습니다. 독감백신처럼 매년 맞는 일정으로 정해져 있지 않습니다.

왜 중증 위험을 보고 권하나요?

강의에 소개된 국내 노인 자료에서 해마다 4~6%가 감염되고, 감염자의 5~10%가 입원했습니다. 입원환자 사망률은 7~10%였습니다. 이 수치는 입원한 환자군의 결과이며 모든 감염자의 사망률을 뜻하지 않습니다.

다른 제품이 나와도 자동으로 다시 맞지는 않습니다

연자 Q&A에서는 아렉스비(Arexvy)를 1회 접종한 분에게 아브리스보(Abrysvo)를 추가로 접종하도록 권하지 않는다고 설명했습니다. 이전 접종 날짜와 제품명을 가져오세요.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

50~74세라면 이런 위험 요인을 함께 봅니다

나이만으로 모두에게 같은 접종 계획을 정하지 않습니다. 단순 고혈압은 강의의 만성 심혈관 위험 질환에서 제외합니다.

강의에 제시된 중증 RSV 위험 요인

심장·폐	만성 심혈관 질환(심부전·관상동맥질환·선천성 심장질환 등, 단순 고혈압 제외), COPD·폐기종·천식·간질성 폐질환 등 만성 폐·호흡기 질환
신장·당뇨	말기 신장질환 또는 투석 등 신대체요법 의존. 장기 손상이 동반되거나 인슐린·SGLT2 억제제 치료가 필요한 당뇨병
신경·근육	기도의 분비물을 잘 배출하지 못하거나 호흡근이 약해지는 신경·신경근육 질환. 기도 청소 장애가 없는 뇌졸중 병력은 제외
그 밖의 위험	간경변 등 만성 간질환, 겸상적혈구병·지중해빈혈 등 만성 혈액질환, 체질량지수(BMI) 40 kg/m² 이상 중증 비만, 중등도·중증 면역저하, 요양시설 거주

비용과 기대 효과를 함께 이야기합니다

연자 Q&A에서는 비용이 높더라도 75세 이상, 또는 만성 심폐질환·면역저하 등 중증 위험이 높은 50~74세에게는 접종을 적극적으로 설명할 가치가 있다고 답했습니다.

접종 상담에 가져갈 정보

1. 이전 RSV 접종 날짜와 제품명
2. 나이, 심장·폐·신장·간 질환과 당뇨 치료 내용
3. 면역저하 여부, 요양시설 거주 여부

예방 효과와 안전성을 함께 이해해요

강의에 소개된 연구 결과입니다. 연구마다 대상과 평가 기준이 달라 제품 간 숫자를 단순 순위로 읽지는 않습니다.

아렉스비 연구에서 본 효과

첫 시즌	60세 이상 연구에서 RSV 하기도 질환 예방 효능 82.6%, 중증 하기도 질환 94.1%, 급성 호흡기 감염 71.7%였습니다.
시간이 지나면	1회 접종군의 시즌별 하기도 질환 예방 효능은 첫 시즌 82.6%, 둘째 56.1%, 셋째 48.0%였습니다.
재접종 연구	3시즌 누적 효능은 1회군 62.9%, 재접종군 69.8%였습니다. 통계적으로 뚜렷한 차이를 보이지 않아 정기 반복 일정은 권고하지 않습니다.

일상 진료 자료에서도 입원·응급실 방문 감소

강의에 소개된 미국 60세 이상 자료에서는 입원 예방 효과 80%, 응급실 방문 예방 효과 77%였습니다. 접종 후 시간이 지날수록 효과가 약해지는 양상도 함께 설명했습니다.

드문 길랭–바레증후군 위험도 논의했습니다

백신 100만 회당 추가 위험 추정은 아렉스비 5.2건, 아브리스보 18.2건이었습니다. 아렉스비 추정 범위는 −0.9~9.2건, 아브리스보는 9.8~23.3건입니다. 강의는 예방 이득과 이 드문 위험을 함께 설명했습니다.

접종의 핵심은 대상·1회·이전 기록입니다

내 중증 위험에 맞는지 살피고, 접종 여부와 제품명을 기록합니다. 현재 강의의 권고는 75세 이상 또는 50~74세 고위험군의 1회 접종입니다.